

Síndrome diarreico agudo: indicaciones de estudio y de tratamiento antibiótico

A quién estudiar y con qué · Cuándo el antibiótico ayuda y cuándo hace daño · Tratamiento por agente específico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: SHU: síndrome hemolítico urémico · STEC/ECEH: *E. coli* productora de toxina Shiga / enterohemorrágica · ETEC: *E. coli* enterotoxigénica · PSD: parasitológico seriado de deposiciones · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · SII: síndrome de intestino irritable · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · SRO: sales de rehidratación oral.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de diagnóstico y manejo de la diarrea infecciosa (Shane, 2017), la guía ACG de diarrea aguda del adulto (2016), las recomendaciones OMS de rehidratación, y la normativa de vigilancia de enfermedades transmisibles del MINSAL. **La diarrea con sospecha de brote o de intoxicación alimentaria, el cólera y otras enfermedades entéricas son de notificación obligatoria: verificar el decreto vigente.**

Índice

1. Definiciones y enfoque sindrómico
2. Diarrea inflamatoria frente a no inflamatoria
3. A quién estudiar
4. Qué exámenes pedir
5. Paneles moleculares: virtudes y trampas
6. El pilar del tratamiento: hidratación
7. Antidiarreicos: cuándo sí y cuándo no
8. Cuándo indicar antibiótico empírico
9. Cuándo NO indicar antibiótico
10. Tratamiento por agente específico
11. Diarrea del viajero
12. Diarrea en el paciente hospitalizado
13. Diarrea en el inmunosuprimido
14. Diarrea persistente y crónica
15. Prevención y notificación
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. Definiciones y enfoque sindrómico

- **Diarrea aguda:** ≥ 3 deposiciones alteradas al día, de **menos de 14 días** de duración.
- **Persistente:** 14-29 días. **Crónica:** ≥ 30 días.
- **Disentería:** diarrea con **sangre y mucus**, con fiebre y pujo — indica compromiso inflamatorio del colon.

La mayoría de las diarreas agudas son **virales, autolimitadas y no requieren estudio ni antibiótico**. El trabajo clínico consiste en identificar la minoría que sí lo requiere.

2. Diarrea inflamatoria frente a no inflamatoria

	No inflamatoria (secretor)	Inflamatoria (invasora)
Mecanismo	Toxinas, invasión limitada al intestino delgado	Invasión y destrucción de la mucosa colónica
Volumen	Grande , acuoso	Escaso, frecuente
Sangre / mucus	No	Sí
Fiebre	Ausente o baja	Alta
Dolor	Cólico periumbilical	Tenesmo, pujo, dolor en fosa ilíaca izquierda
Leucocitos fecales	Ausentes	Presentes
Agentes	Norovirus, rotavirus, ETEC, <i>S. aureus</i> , <i>B. cereus</i> , <i>C. perfringens</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>	<i>Shigella</i>, <i>Campylobacter</i>, <i>Salmonella</i> no tifoidea, STEC, <i>Yersinia</i>, <i>E. histolytica</i>, <i>C. difficile</i>

Un dato de la historia orienta mucho: el tiempo de incubación.

Latencia	Agente probable
1-6 horas , vómitos predominantes	Toxina preformada: <i>S. aureus</i> , <i>Bacillus cereus</i> (arroz)
8-16 horas	<i>Clostridium perfringens</i> , <i>B. cereus</i> (forma diarreica)
16-72 horas	<i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , ETEC, virus
Días a semanas	Parásitos, <i>Yersinia</i> , tuberculosis intestinal

3. A quién estudiar

No requieren estudio la mayoría de las diarreas acuosas, leves, de menos de 7 días, en pacientes inmunocompetentes sin factores de riesgo.

Sí se estudia si hay:

- **Diarrea con sangre** o disentería. - **Fiebre** $\geq 38,5$ °C. - **Deshidratación grave** o necesidad de hospitalización. - **Dolor abdominal intenso**, sobre todo en > 50 años (diferencial con isquemia). - **Duración** > 7 días o diarrea persistente. - **Inmunosupresión:** VIH, trasplante, quimioterapia, corticoides, biológicos. - **Sospecha de brote** o de intoxicación alimentaria colectiva. - **Antibiótico reciente u hospitalización** -> estudio de *C. difficile*. - **Viaje reciente** a zonas de riesgo. - **Manipulador de alimentos, trabajador de salud o de sala cuna** (por implicancias de salud pública). - **Enfermedad inflamatoria intestinal** conocida (para descartar sobreinfección).

4. Qué exámenes pedir

Examen	Comentario
Coprocultivo	Detecta <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Yersinia</i> . Solicitar específicamente STEC/O157 si hay diarrea sanguinolenta: los medios habituales pueden no detectarla
Panel molecular gastrointestinal	PCR múltiple; sensibilidad muy superior y resultado rápido (sección 5)
Toxina y PCR de <i>C. difficile</i>	Si hay antibiótico previo, hospitalización o factores de riesgo. Ver documento específico
Parasitológico seriado (3 muestras)	Diarrea > 7-14 días, viaje, inmunosupresión, contacto con agua no potable
Antígenos de <i>Giardia</i>, <i>Cryptosporidium</i>, <i>E. histolytica</i>	Mayor rendimiento que la microscopía
Leucocitos fecales / lactoferrina / calprotectina	Diferencian inflamatoria de no inflamatoria; poco específicos y de uso decreciente
Hemocultivos	Fiebre alta, sepsis, inmunosupresión, sospecha de fiebre tifoidea
Exámenes generales	Función renal, electrolitos, hemograma. Ante diarrea sanguinolenta: hemograma con frotis, LDH, creatinina y plaquetas para pesquisar SHU
Endoscopia	Diarrea persistente sin diagnóstico, sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis en inmunosuprimido

Examen	Comentario
Imagen	Sospecha de megacolon tóxico, isquemia, perforación

5. Paneles moleculares: virtudes y trampas

- **Ventajas:** detectan simultáneamente 15-25 agentes (bacterias, virus y parásitos), con sensibilidad muy superior al cultivo y resultado en horas; funcionan pese al antibiótico previo.
- **Trampas:**
 - **Detectan ácido nucleico, no viabilidad ni patogenicidad:** pueden identificar portación o eliminación asintomática.
 - **Codetecciones frecuentes,** cuyo significado clínico requiere juicio.
 - **La PCR de *C. difficile* positiva no distingue infección de portación** (10-15 % de los adultos hospitalizados son portadores): hay que interpretarla junto con la clínica y, cuando esté disponible, con la detección de toxina.
 - **No entregan susceptibilidad:** si se necesita antibiograma o tipificación (vigilancia, brote, notificación), **hay que enviar cultivo.**
- **Regla práctica:** un resultado positivo se trata **sólo si el cuadro clínico corresponde** y si el agente tiene indicación de tratamiento.

6. El pilar del tratamiento: hidratación

- **Sales de rehidratación oral** de osmolaridad reducida son el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, incluida la diarrea grave. La glucosa de la fórmula aprovecha el cotransporte sodio-glucosa, que permanece intacto incluso en el cólera.
- **Hidratación endovenosa** si hay vómitos incoercibles, shock, íleo o deshidratación grave.
- **Mantener la alimentación:** no se recomienda el ayuno. Dieta habitual, evitando lácteos si hay intolerancia transitoria y bebidas con alto contenido de azúcares.
- **Zinc** tiene beneficio demostrado en niños en países de baja renta; no es parte del manejo habitual del adulto.
- **Probióticos:** evidencia heterogénea; no forman parte del tratamiento estándar de la diarrea aguda del adulto.

7. Antidiarreicos: cuándo sí y cuándo no

- **Loperamida** es útil en la **diarrea acuosa no inflamatoria** del adulto inmunocompetente, y en la **diarrea del viajero** asociada a antibiótico, donde acorta la duración de los síntomas.
- **Está contraindicada** —o debe evitarse— si hay:
 - **Diarrea sanguinolenta o disentería.**
 - **Fiebre alta.**
 - **Sospecha de STEC** (aumenta el riesgo de SHU).
 - **Sospecha o confirmación de *C. difficile*** (riesgo de megacolon tóxico).
 - Sospecha de colitis inflamatoria u obstrucción.
- **Subsalicilato de bismuto:** alternativa razonable, con menor riesgo.

8. Cuándo indicar antibiótico empírico

La mayoría de las diarreas agudas **no requiere antibiótico**. Se considera empírico si hay:

- **Disentería con fiebre alta** y compromiso del estado general (sospecha de *Shigella* o *Campylobacter*), **una vez descartada razonablemente STEC.**
- **Sepsis o toxicidad sistémica.**
- **Inmunosupresión significativa** (VIH avanzado, neutropenia, trasplante, cirrosis).
- **Sospecha de fiebre tifoidea** o de cólera.
- **Diarrea del viajero moderada a grave.**
- **Prótesis valvular, prótesis vascular o material protésico** con diarrea invasora (riesgo de siembra).
- **Adulto mayor de 70 años con enfermedad grave.**

Esquema empírico habitual: azitromicina 500 mg/día por 3 días (preferida por la resistencia creciente de *Campylobacter* a quinolonas), o ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por 3 días según el patrón local.

9. Cuándo NO indicar antibiótico

- **Diarrea acuosa leve o moderada** sin fiebre en un inmunocompetente. - **Sospecha de STEC / *E. coli* O157:H7** — el antibiótico **aumenta el riesgo de síndrome hemolítico urémico**, por incremento de la liberación de toxina Shiga. Es la contraindicación más importante de esta sección. - **Salmonelosis no tifoidea no complicada** en un adulto sano: **el antibiótico no acorta el cuadro y prolonga la portación**. - **Intoxicación por toxina preformada** (*S. aureus*, *B. cereus*): es tóxica, no infecciosa. - **Diarrea viral**. - **Portación asintomática**.

Cuándo sospechar STEC: diarrea **sanguinolenta sin fiebre alta o con fiebre baja**, dolor abdominal intenso, antecedente de carne mal cocida, lácteos no pasteurizados o contacto con ganado. **Vigilar el SHU** con hemograma, frotis (esquistocitos), LDH, plaquetas y creatinina.

10. Tratamiento por agente específico

Agente	¿Tratar?	Esquema
<i>Salmonella</i> no tifoidea	No , si es un adulto sano con cuadro no complicado. Sí en: < 6 meses o > 50 años, inmunosupresión, prótesis valvular o vascular, aneurisma, enfermedad valvular, hemoglobinopatía, bacteriemia, sepsis	Ciprofloxacino o ceftriaxona por 7-14 días (más prolongado si hay bacteriemia o foco endovascular)
<i>Salmonella typhi</i> / <i>paratyphi</i> (fiebre tifoidea)	Sí, siempre	Ceftriaxona 2 g/día o azitromicina; 7-14 días. Resistencia creciente a quinolonas. Buscar portación crónica biliar. Notificación obligatoria
<i>Shigella</i>	Sí (acorta el cuadro y reduce la transmisión)	Azitromicina 500 mg/día por 3 días o ciprofloxacino; vigilar resistencia
<i>Campylobacter</i>	Sólo si es grave, prolongado o en inmunosuprimido	Azitromicina 500 mg/día por 3 días (alta resistencia a quinolonas). Asociación con síndrome de Guillain-Barré
<i>STEC / E. coli</i> O157:H7	NO	Soporte . Vigilar SHU. Evitar antibióticos y antimotílicos
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Sólo si es grave o hay bacteriemia	Cotrimoxazol, quinolona o ceftriaxona. Puede simular apendicitis (adenitis mesentérica). Riesgo aumentado en sobrecarga de hierro
<i>Vibrio cholerae</i>	Sí , además de la rehidratación intensiva	Doxiciclina en dosis única o azitromicina. Notificación obligatoria inmediata
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Habitualmente no	Soporte; doxiciclina si es grave
<i>Clostridioides difficile</i>	Sí	Ver documento específico
<i>Giardia</i>	Sí	Metronidazol 250-500 mg cada 8 h por 5-7 días, o tinidazol 2 g dosis única
<i>Entamoeba histolytica</i>	Sí	Metronidazol o tinidazol, seguido de un amebicida luminal (paromomicina) para erradicar quistes
<i>Cryptosporidium</i>	En inmunocompetente, autolimitado. En VIH: restaurar la inmunidad	Nitazoxanida; en VIH lo esencial es la terapia antirretroviral
<i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>	Sí	Cotrimoxazol
Toxina preformada (<i>S. aureus</i> , <i>B. cereus</i>)	No	Soporte

11. Diarrea del viajero

- **Agente más frecuente:** *E. coli* enterotoxigénica; también *Campylobacter*, *Shigella*, *Salmonella*, norovirus y, en cuadros prolongados, *Giardia* y *Cyclospora*.
- **Leve** (tolerable, sin limitar la actividad): **hidratación y loperamida**; no requiere antibiótico.

- **Moderada:** loperamida más **azitromicina 1 g en dosis única** o 500 mg/día por 3 días.
- **Grave o disintérica:** **azitromicina** (de elección, especialmente en el sudeste asiático por la resistencia de *Campylobacter* a quinolonas); alternativas según región.
- **La profilaxis antibiótica no se recomienda de rutina;** se considera en viajeros de muy alto riesgo por períodos breves (rifaximina o subsalicilato de bismuto).
- **Prevención:** higiene de manos y precauciones con agua y alimentos.
- **Ojo con la selección de resistencia:** el viaje a zonas de alta prevalencia, especialmente con uso de antibióticos, es un factor de riesgo reconocido de **colonización por enterobacterias BLEE**.

12. Diarrea en el paciente hospitalizado

- **La primera causa a considerar es *C. difficile***, pero también hay que revisar sistemáticamente las causas no infecciosas, que son frecuentes:
 - **Fármacos:** laxantes, procinéticos, magnesio, inhibidores de bomba de protones, metformina, colchicina, quimioterápicos, **inhibidores de puntos de control inmunitario** (colitis inmune), alimentación enteral hiperosmolar.
 - **Isquemia intestinal**, impactación fecal con rebosamiento, enfermedad inflamatoria intestinal, malabsorción, sobrecrecimiento bacteriano.
- **Los coprocultivos y paneles pierden rendimiento** en la diarrea que comienza **después de 72 horas de hospitalización:** la conducta es estudiar *C. difficile* y revisar fármacos, no repetir coprocultivos.
- **Precauciones de contacto** ante diarrea infecciosa sospechada, e **higiene de manos con agua y jabón** (no alcohol gel) si se sospecha *C. difficile* o norovirus, cuyas esporas y cápsides resisten al alcohol.

13. Diarrea en el inmunosuprimido

Población	Agentes a considerar además de los habituales
VIH avanzado	<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cystoisospora</i> , <i>Cyclospora</i> , microsporidios, CMV (colitis), complejo <i>M. avium</i> , <i>Salmonella</i> recurrente, <i>C. difficile</i>
Trasplante	CMV , <i>C. difficile</i> , adenovirus, norovirus prolongado, enfermedad injerto contra huésped
Neutropenia	Tiflitis (colitis neutropénica): fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, engrosamiento cecal en la tomografía. Manejo médico con antibióticos de amplio espectro y reposo intestinal; cirugía sólo si hay perforación o hemorragia
Corticoides o biológicos	<i>Strongyloides</i> — hiperinfección , con diarrea, íleo y bacteriemia polimicrobiana por translocación. Descartar antes de inmunosuprimir
Anti-TNF, anti-integrinas	Reactivación de tuberculosis intestinal, <i>C. difficile</i>
Inhibidores de puntos de control	Colitis inmunomediada , que se trata con corticoides, no con antibióticos

El estudio en el inmunosuprimido es **más amplio y más precoz**, e incluye **endoscopia con biopsia** cuando el estudio no invasivo no da el diagnóstico.

14. Diarrea persistente y crónica

Ante diarrea de más de 14 días:

1. **Repetir y ampliar el estudio parasitológico** (*Giardia*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora*, *Strongyloides*).
2. **Descartar *C. difficile*.**
3. **Considerar causas post-infecciosas:** intolerancia transitoria a la lactosa, sobrecrecimiento bacteriano, **síndrome de intestino irritable post-infeccioso** (frecuente y subdiagnosticado).
4. **Considerar causas no infecciosas:** enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática exocrina, colitis microscópica, hipertiroidismo, neoplasia, fármacos.
5. **Estudio de VIH.**
6. **Endoscopia con biopsias** si el estudio no invasivo es negativo.

15. Prevención y notificación

- **Higiene de manos**, manipulación segura de alimentos, agua potable, cadena de frío.

- **Precauciones de contacto** en el paciente hospitalizado con diarrea infecciosa; habitación individual si es posible.
- **Notificación obligatoria:** cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea, y los **brotos de enfermedades transmitidas por alimentos**, que además activan la investigación epidemiológica de la autoridad sanitaria. **Verificar el decreto de notificación obligatoria vigente del MINSAL;** la confirmación y tipificación de cepas se realiza en el ISP.
- **Exclusión laboral** de manipuladores de alimentos y de personal de salud según la normativa, hasta la resolución del cuadro o la documentación de negativización cuando corresponda.

16. Errores frecuentes

- **Dar antibiótico a toda diarrea**, incluida la acuosa leve. - **Tratar una salmonelosis no complicada** en un adulto sano: prolonga la portación. - **Dar antibiótico ante sospecha de STEC:** aumenta el riesgo de síndrome hemolítico urémico. - **Usar loperamida en disentería o en *C. difficile*.** - **Pedir coprocultivos** en un paciente que lleva más de 72 horas hospitalizado, en lugar de estudiar *C. difficile* y revisar fármacos. - **Tratar todo hallazgo de un panel molecular** sin correlato clínico. - **Interpretar una PCR de *C. difficile* positiva** como infección sin evaluar la clínica. - **Pedir una sola muestra** para parasitológico. - **No buscar SHU** en la diarrea sanguinolenta. - **No descartar *Strongyloides*** antes de indicar corticoides en un paciente con exposición compatible. - **No notificar** un brote de enfermedad transmitida por alimentos.

17. Perlas de alto rendimiento

- La mayoría de las diarreas agudas son virales y no requieren estudio ni antibiótico.
- La hidratación es el tratamiento; las sales de rehidratación oral funcionan incluso en el cólera.
- Vómitos en las primeras 6 horas = toxina preformada (*S. aureus*, *B. cereus*).
- Diarrea sanguinolenta -> pedir STEC específicamente y NO dar antibiótico.
- Loperamida está contraindicada en disentería, STEC y *C. difficile*.
- Salmonelosis no tifoidea no complicada en adulto sano: no tratar. Sí tratar si hay prótesis vascular, aneurisma, inmunosupresión o bacteriemia.
- Azitromicina es el empírico preferido por la resistencia de *Campylobacter* a quinolonas.
- *Campylobacter* se asocia a síndrome de Guillain-Barré; *Yersinia* simula apendicitis.
- La amebiasis requiere un amebicida luminal después del metronidazol.
- Diarrea que empieza tras 72 h de hospitalización: pensar en *C. difficile* y en fármacos, no en coprocultivo.
- Alcohol gel no sirve frente a *C. difficile* ni norovirus: agua y jabón.
- Diarrea persistente: parásitos, post-infecciosa o no infecciosa; y siempre considerar VIH.

18. Bibliografía esencial

- Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. *Clin Infect Dis*. 2017;65:e45-e80.
- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG clinical guideline: diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults. *Am J Gastroenterol*. 2016;111:602-22.
- Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, et al. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report. *J Travel Med*. 2017;24(Suppl 1):S57-S74.
- Freedman SB, Xie J, Neufeld MS, et al. Shiga toxin-producing *Escherichia coli* infection, antibiotics, and risk of developing hemolytic uremic syndrome: a meta-analysis. *Clin Infect Dis*. 2016;62:1251-8.
- Johnson SW, Lavergne V, Skinner AM, et al. IDSA/SHEA 2021 focused update guidelines on management of *Clostridioides difficile* infection in adults. *Clin Infect Dis*. 2021;73:e1029-44.
- World Health Organization. The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. Edición vigente.
- Ministerio de Salud de Chile. Decreto de enfermedades de notificación obligatoria y normas de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos. Verificar versión vigente.